

15. DESARROLLO DE LA LENGUA Y TIROIDES

DURACIÓN : 07:43

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este vídeo explora los complejos procesos de desarrollo de la lengua y la tiroides durante la embriogénesis, haciendo hincapié en el enderezamiento embrionario y sus implicaciones en la dinámica postural. Se abordan prácticas como la estabilización de la lengua y la interacción con el cartílago tiroides, destacando la importancia de las estructuras que rodean el foramen ciego. Los instructores también examinan el impacto de los arcos branquiales y los tejidos embrionarios en el desarrollo general, así como la importancia de los fulcros en el cuerpo, especialmente a través de la pelvis. Estos conceptos son cruciales para los profesionales que buscan integrar un enfoque holístico en su trabajo osteopático.

DESARROLLO DE LA LENGUA Y LA TIROIDES

En el momento de la **flexión** y el **enderezamiento** del embrión, el tubo digestivo se posiciona inicialmente bastante bajo. Al observar el **paladar**, se nota que presenta una forma ojival, mientras que antes era más bien bajo. Este enderezamiento se acompaña de un **descenso de los pterigoides** y de una tracción que eleva el tubo digestivo.

Este proceso de desarrollo es crucial para la formación de la **lengua** y de la **tiroides**, que proviene de la lengua. En el corte embrionario, se observa la parte **endodérmica** así como los arcos faríngeos numerados (1, 2, 3, 4). En el arco faríngeo número 1, en el momento del enderezamiento, aparece la **capa de la lengua lateral**. Entre el arco branquial número 2 y esta capa, se forma un **tubérculo impar** y un pequeño orificio, el **foramen ciego**.

El foramen ciego, que se desarrolla con la lengua, es esencial para la formación del sistema tiroideo. Este desarrollo se caracteriza por un **crecimiento global**, con un punto fijo que actúa como punto de apoyo. La profundidad de la lengua está relacionada con la **profundidad de la encefalización**.

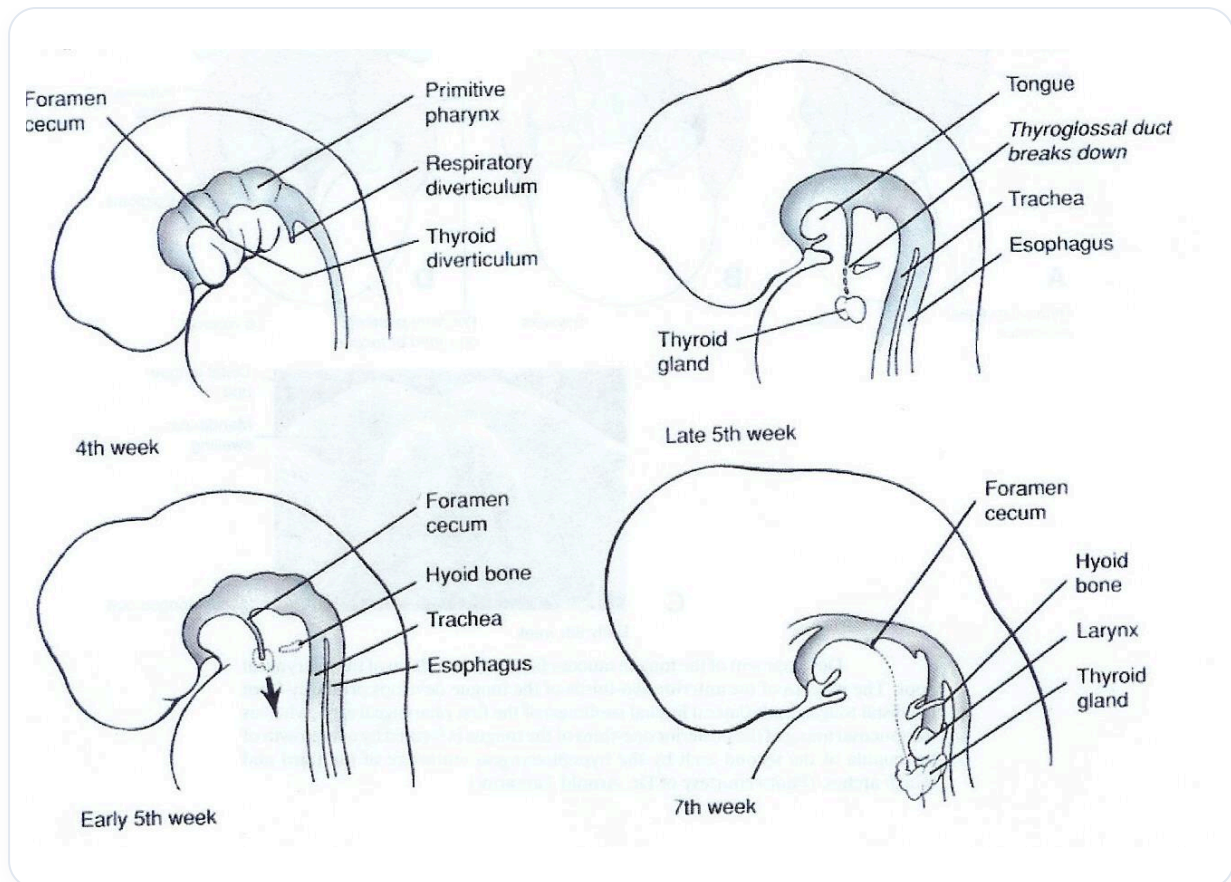


FIG. — Desarrollo tiroideo embrionario

El enderezamiento embrionario revela el foramen ciego, que es crucial para la formación de las estructuras circundantes. Otro corte muestra el **cartílago de Meckel** y la lengua. Es importante señalar que las flechas en las ilustraciones deben estar orientadas correctamente para comprender la dinámica de este desarrollo.

Existe un desgarramiento entre la lengua y el diafragma, donde el **cartílago tiroideo** se convierte en un punto de apoyo. Estabilizar la lengua y el aire vago es esencial para mantener el equilibrio a nivel del cartílago tiroideo y del hueso hioides. La lengua desempeña un papel fundamental en la actividad postural, y el niño comienza a enderezarse con la aparición de sus primeros dientes, utilizando su lengua como punto de apoyo.

La lengua busca **taponar los pequeños orificios** durante la deglución, y su movimiento puede influir en el eje longitudinal del cuerpo, llegando hasta la **pelvis**. Las desviaciones de la pelvis pueden ser el reflejo de un desequilibrio oclusal, relacionado con la dinámica lingual.

Los dientes son zonas de **densificación** y pueden conservar memorias, lo que influye en la dinámica corporal. En esta fase de desarrollo, también se observan las **amígdalas palatinas**, la **paratiroides**, el **timo**, y el **cuerpo ultimobranquial**. Cada arco branquial (mandibular, tiroideo, laríngeo superior e inferior) está interconectado, y el tejido endodérmico desempeña un papel central en esta dinámica.

El desarrollo embrionario se lleva a cabo durante un período específico, con el **cierre del tubo neural** el día 27 y el enderezamiento completo del embrión después del primer mes. La formación del embrión se completa entre el segundo y el tercer mes, con estructuras bien definidas.

Los tejidos embrionarios se influyen mutuamente: el **ectodermo** y el **endodermo** dependen del **mesodermo**, que asegura la transmisión de la información nutritiva. Esta dinámica es esencial para comprender el desarrollo de la lengua, la tiroides y la paratiroides.

Es crucial seguir los **fulcros** en el cuerpo, ya que se manifiestan en la práctica. El **ombligo** es un gran fulcro, y es esencial que la pelvis esté despejada y libre para un buen funcionamiento. En la práctica osteopática, el tratamiento de la pelvis es a menudo una prioridad, ya que está relacionado con la **sínfisis esfenobasilar**. Trabajar sobre el sacro o la pelvis influye directamente en esta sínfisis, permitiendo así un enfoque holístico del cuerpo.

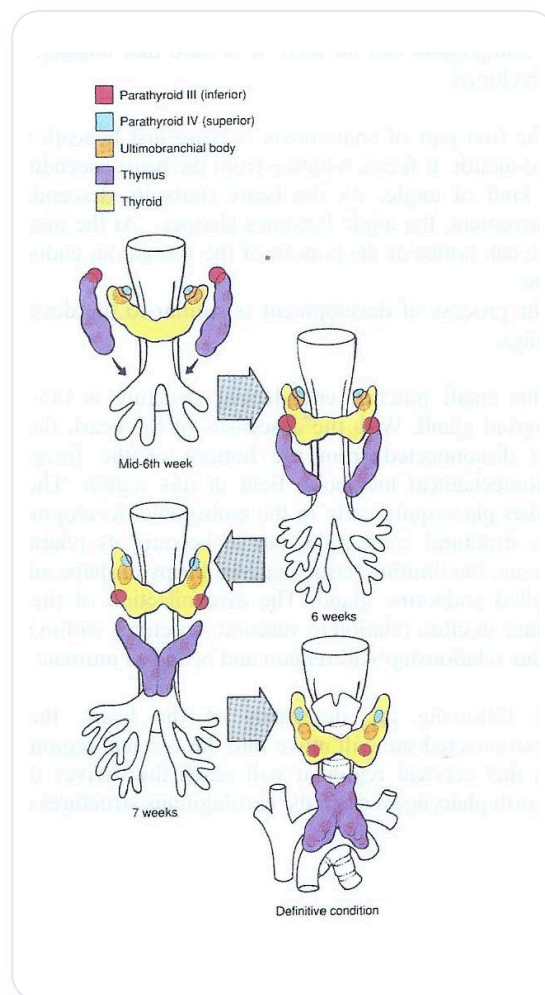


FIG. — Desarrollo de la tiroides y paratiroides

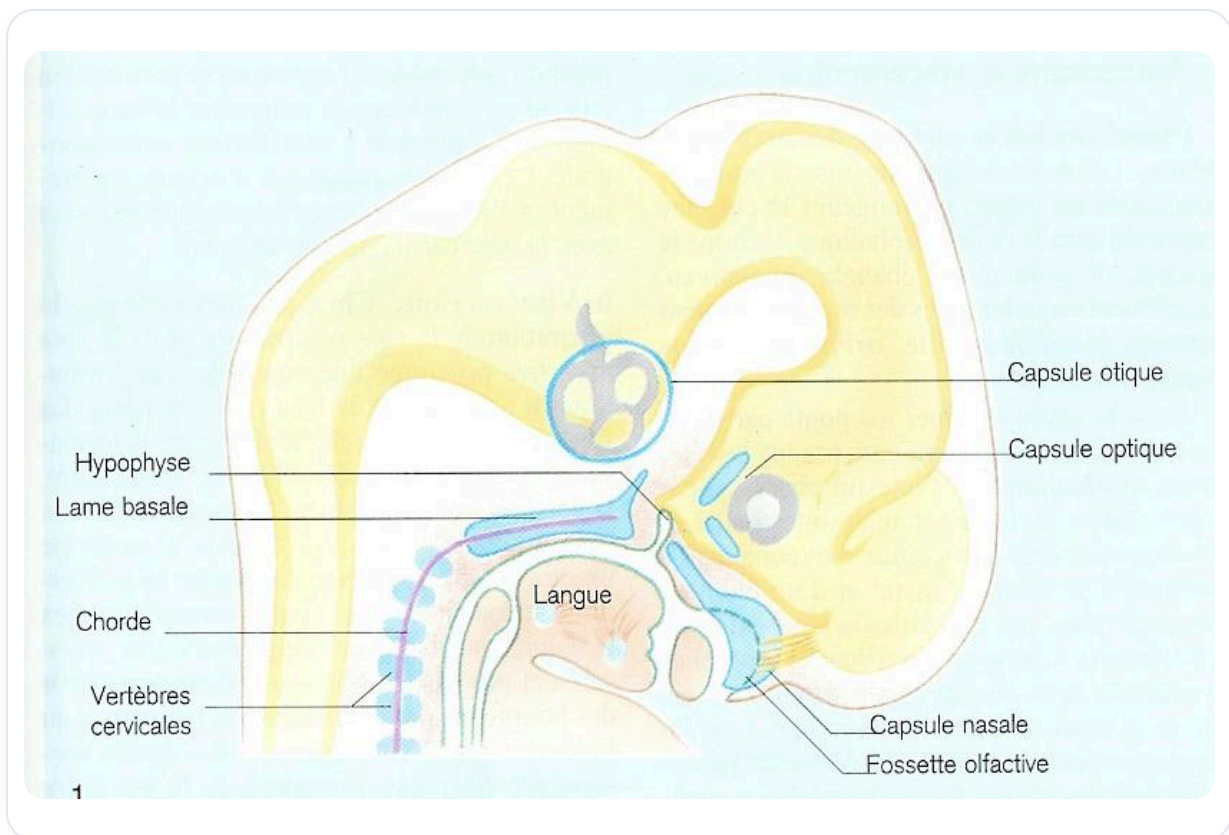


FIG. — Embríon humano sagital

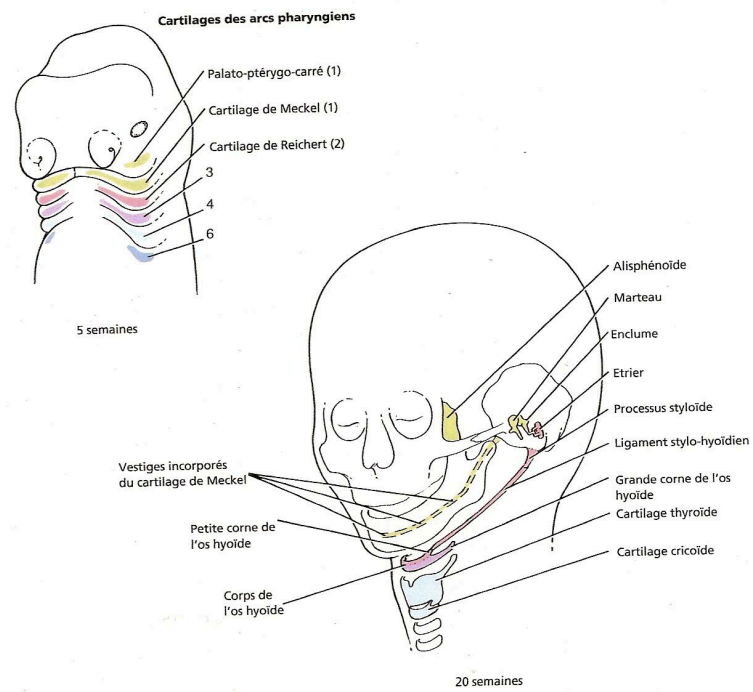


Fig. 12 - 5. Devenir des cartilages des arcs pharyngiens. Ces cartilages donnent un petit os de l'orbite, les éléments squelettiques des mâchoires, les trois osselets de l'oreille, l'os hyoïde et le squelette du larynx.

FIG. — Desarrollo de los arcos faríngeos

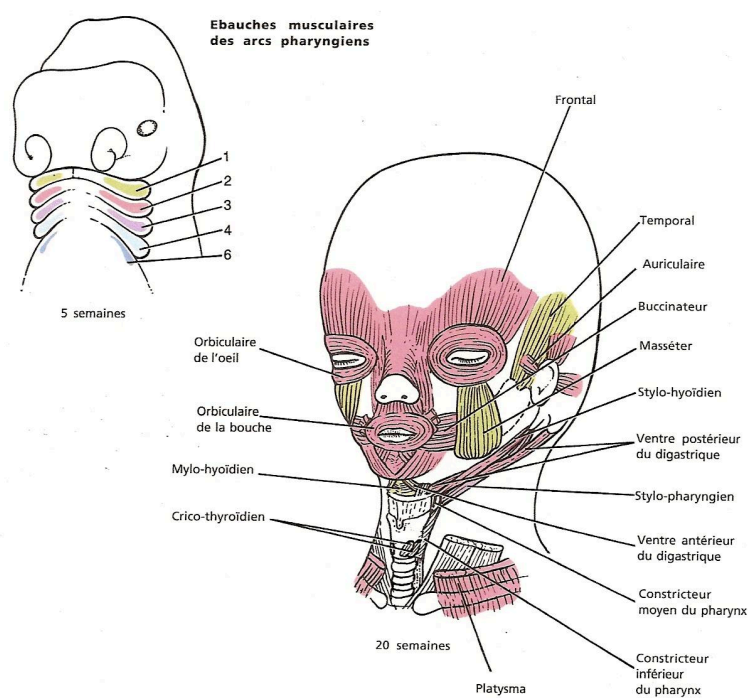


Fig. 12 - 7. Devenir de la musculature des arcs pharyngiens. Les muscles des arcs pharyngiens se développent à partir du mésoblaste para-axial qui se constitue principalement à partir des somitomères crâniens et des somites occipitaux. Les myoblastes du sixième arc fournissent la musculature intrinsèque du larynx (non représentée).

FIG. — Musculatura de los arcos faríngeos

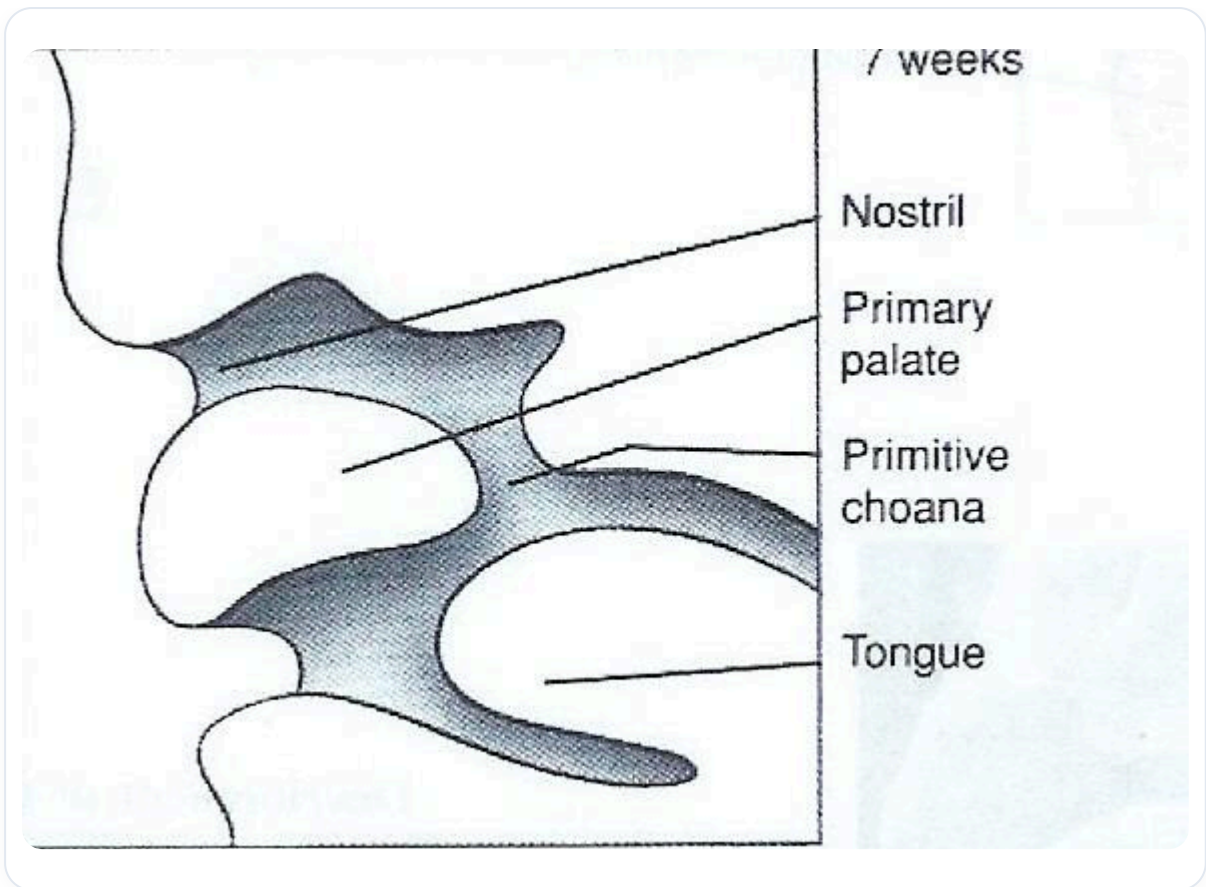


FIG. — Desarrollo del paladar en el embrión

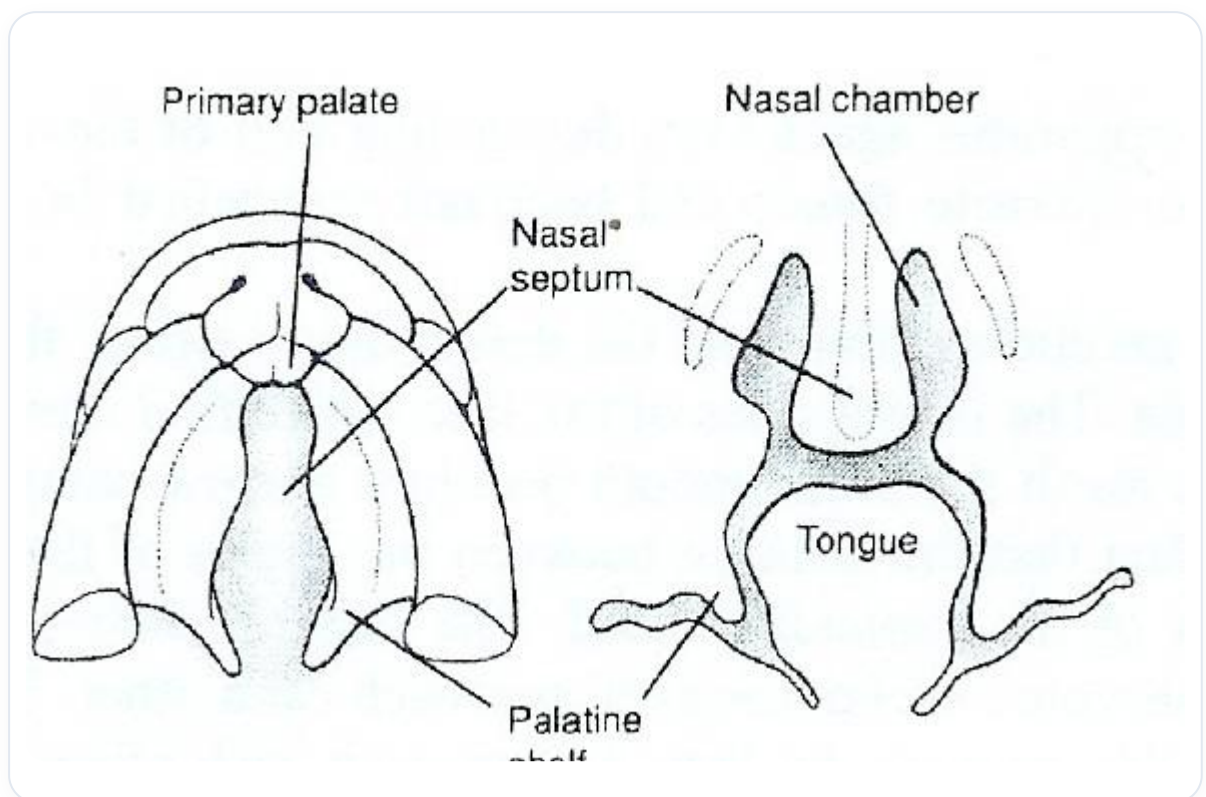


FIG. — Desarrollo del paladar y la nariz

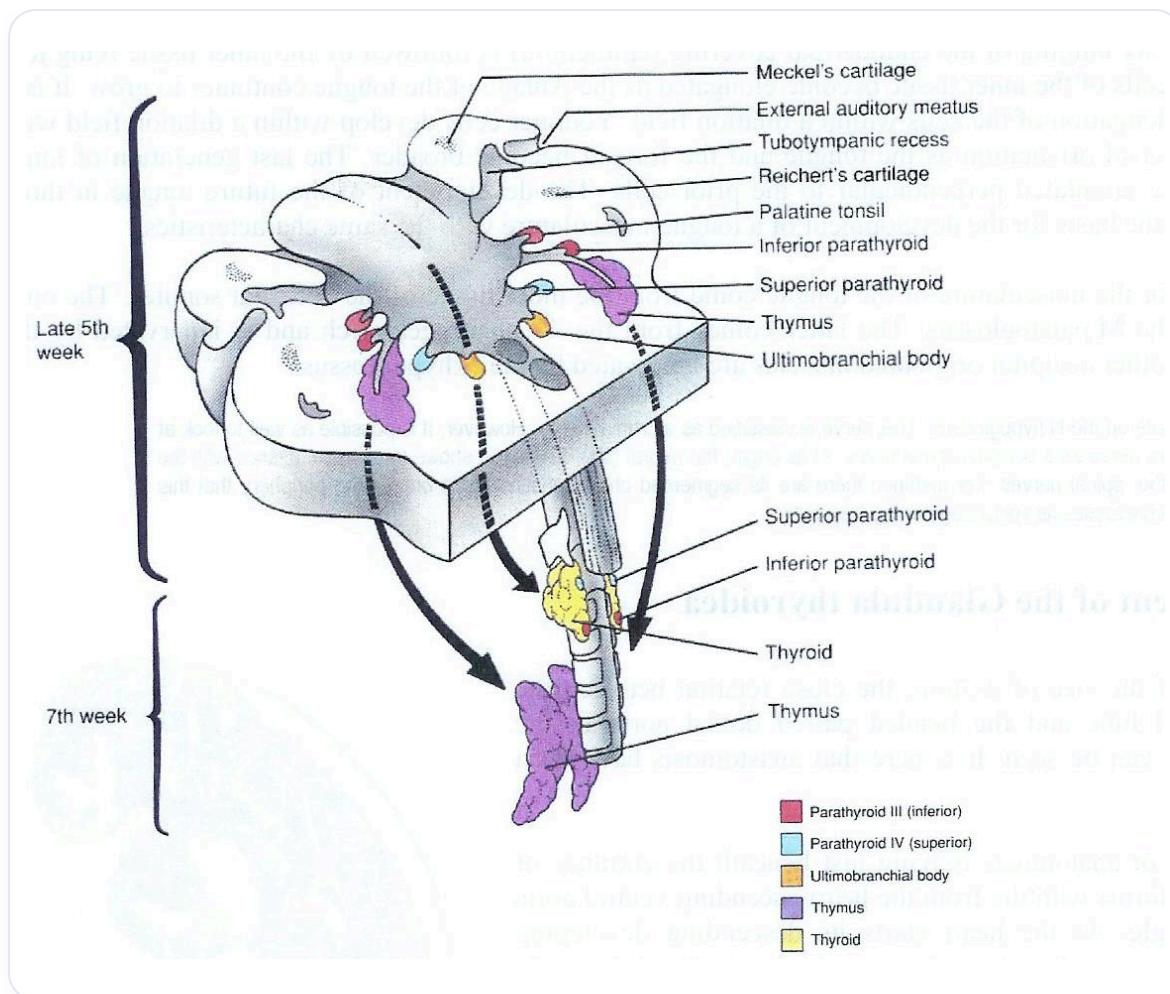


FIG. — Desarrollo faríngeo